Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa

Rua Buenos Aires, 919 - Bairro: Centro - CEP: 98780735 - Fone: (55)3029-9979 - Email: frsantrosa2vcri@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5001041-65.2023.8.21.0028/RS

REQUERENTE: GUSTAVO MARCHALEK DE BRITO
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos etc.

GUSTAVO MARCHALEK DE BRITO, representado por seus genitores LEONARDO PEGAS DE BRITO e LEILA MARCHALEK DE BRITO, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela satisfativa contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, visando à condenação da parte requerida ao fornecimento do medicamento CANABIDIOL 20MG/ML, a ser administrado de forma contínua e por tempo indeterminado, na quantidade de 7 caixas/mês. Alegou a parte autora, em síntese, que é portador de autismo. Disse que o pedido administrativo do medicamento foi realizado junto a Secretaria de Saúde do Município, sendo informado que não é disponibilizado pelo SUS. Sustentou que que seus genitores não dispõem de condições de arcar com os custos mensais do tratamento indicado. Requereu o deferimento de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o requerido forneça o medicamento CANABIDIOL 20MG/ML ou o valor correspondente em dinheiro para adquiri-lo, sob pena de bloqueio de valores. Ao final, postulou a procedência do pedido, confirmando-se a liminar. Ainda, pleiteou a gratuidade judiciária e a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Houve a declinação da competência do presente processo para este Juizado da Infância e Juventude desta Comarca (evento 7, DESPADEC1).

A tutela de urgência foi deferida (**evento 12, DESPADEC1**).

Sobreveio pedido de bloqueio de valores, diante do nãoatendimento da tutela de urgência deferida (evento 29, PET1), o que foi acolhido (evento 31, DESPADEC1).

Citado (evento 28), o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apresentou contestação (evento 38, CONT1). Requereu, em síntese, a extinção do feito, na forma do art. 485, VI, do CPC; alternativamente, seja acolhida a arguição tocante ao cumprimento do tema 793 do STF, determinando-se à parte autora que, em emenda à petição inicial, requeira a citação da União, tudo nos termos do art. 115, parágrafo único, CPC, sob pena de extinção do processo; posteriormente, no caso de emenda para inclusão da União no polo passivo, sejam os autos remetidos à Justiça Federal para processamento e julgamento, nos termos do art. 109, I, CF; superada a preliminar, requer a improcedência da demanda, com a condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais daí advindos; por cautela, no caso de condenação, seja declarada a responsabilidade financeira exclusivamente da UNIÃO quanto à obrigação de custeio do fármaco, haja vista os enunciados nos Temas 500 e 793, ambos do STF; requereu seja oportunizada a produção de todos os meios de provas em direito permitidos, especialmente a produção de prova técnica, mediante a emissão de nota técnica pelo sistema e-NatJus; a intimação da parte autora, a fim de que demonstre a hipossuficiência financeira alegada, mediante a juntada de extratos bancários em nome de ambos os genitores, assim como contracheque da genitora referente aos últimos três meses, e para que esclareça a atividade desempenhada pela empresa L. L. BRITO REPRESENTAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 06.198.288/0001-37), esclarecendo sobre distribuição de dividendos.

Ofertada réplica (evento 41, RÉPLICA1).

Em decisão saneadora (evento 47, DESPADEC1), foi indeferido o pedido de comprovação de condição financeira, considerando que os comprovantes de rendimentos dos genitores do requerente encontram-se nos autos (evento 1, CHEQ10 - e evento 1, CHEQ9), bem como o pedido de emissão de nota técnica pelo e-NatJus (evento 60, DESPADEC1).

Deferidos novos bloqueios de valores (evento 75, DESPAOFC1, evento 105, DESPAOFC1, evento 137, DESPAOFC1), cujas prestações de contas foram devidamente homologadas.

O Ministério Público manifestou-se pela pela procedência do pedido, nos termos da inicial, ratificando-se a tutela provisória concedida (evento 92, PROMOÇÃO1).

Vieram, então, os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Considerando que o presente feito não demanda produção de provas em audiência, procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

In meritis, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GUSTAVO MARCHALEK DE BRITO em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Antes de ingressar na análise do mérito, porém, passo a tecer algumas considerações acerca da legitimidade passiva do demandado em se tratando de demanda para fornecimento de medicamentos.

O direito à saúde é um direito social básico, ao passo que o dever de prestar medicamentos às pessoas com poucos recursos financeiros é obrigação solidária entre o Município, o Estado e a União, de acordo com o que estabelece o artigo 23, II, da Constituição Federal. Além disso, o próprio Estado do Rio Grande do Sul atribui a si próprio a responsabilidade de garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde de seus cidadãos, conforme se extrai do art. 241 da Constituição Estadual do RS.

Logo, em se tratando de responsabilidade solidária, pode o(a) requerente cobrar os medicamentos essenciais à preservação de sua saúde de qualquer um dos três entes.

A esse respeito, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça:

> *APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORA DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA. COMPROVADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS QUESTÕES DE SAÚDE. LEGITIMIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. 1. Evidente a necessidade da menor, justificando-se o fornecimento do medicamento pleiteado, nos termos do* ***pedido****, devendo a tutela de seus interesses se dar com máxima prioridade, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. 2.* ***Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental ao direito à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles.*** *Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontra na lista do outro ente. RECURSO DESPROVIDO, MANTIDA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70068586171, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 13/03/2016). (Grifei).*

O mesmo entendimento é adotado pelos Tribunais Superiores, os quais asseguram que, em consonância com o disposto no art. 196 da Magna Carta, todos os entes são legitimados passivos para este tipo de ação, ocorrendo, *in casu*, a chamada legitimidade concorrente. Portanto, forçoso reconhecer a impossibilidade de se afastar a responsabilidade dos demandados

Assim, nada impede que o autor intente ação unicamente contra o Estado, pleiteando o fornecimento da medicação necessária à manutenção de sua saúde.

No mérito propriamente dito, merece ser acolhido o pedido manejado pela parte autora na peça inaugural.

Como já referido, a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deverá garanti-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas à sua promoção, proteção e recuperação.

Da mesma forma, tanto a saúde quanto a vida são considerados os mais importantes direitos fundamentais de qualquer ser humano, estando plenamente assegurados pela Carta Magna, que, em seus arts. 5º, *caput*, 6º, *caput*, e 196, assim dispõe:

> *"Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros no País a* ***inviolabilidade do direito à vida****, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)".*
>
> *"Art. 6º. São direitos sociais a educação,* ***a saúde****, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".*
>
> *"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".*

Ainda, nesse mesmo sentir, o artigo 241 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul dispõe que:

> *"Art. 241 - A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Parágrafo único - O dever do Estado, garantido por adequada política social e econômica, não exclui o do indivíduo, da família e de instituições e empresas que produzam riscos ou danos à saúde do indivíduo ou da coletividade".*

Ademais, especificamente à obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos quanto ao Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual n. 9.908/93 é expressa ao assim estatuir:

> *"Art. 1.º - O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.*
>
> *Parágrafo único – Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que devem ser usados com freqüência e de forma permanente, sendo indispensável à vida do paciente."*

Cumpre, ainda, esclarecer que não se está a falar em interferência do Poder Judiciário na competência do Poder Executivo, mas apenas na aplicação da lei ao caso concreto, função precípua do primeiro. Se o Estado tem o dever de proporcionar saúde a todos os indivíduos, segundo as já citadas normas constitucionais e não cumpre com tal obrigação, ao prejudicado é inteiramente assegurado o direito de ação, ante a garantia constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, pois, nos termos do art. 5º, XXXV, da Lei Maior, *"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"*. Logo, tal Poder tem a obrigação de dizer e fazer valer o Direito em todos os casos concretos que lhe forem submetidos, sob pena de violar a aludida garantia fundamental.

A parte autora apresenta "TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), associado à desordem do desenvolvimento intelectual e com ausência de linguagem funcional (CID 11: 6A02.5) e requer a concessão do medicamento **CANABIDIOL** 20 mg/ml, não integrado às listas do SUS.

Sobre a questão, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2023, em referendo à tutela provisória incidente no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 (Tema 1234), de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, proferiu a seguinte decisão:

> *REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5.* ***Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:*** *5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;* ***5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;*** *5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. - grifei*

Assim, nas demandas judiciais relativas a medicamentos e tratamentos não incorporados às listas do SUS, não deve haver a declinação da competência, pois, consoante decidido pelo STF, a competência, nesse caso, será definida pelo valor do tratamento anual:

> · *Superior a 210 Salários Mínimos: Justiça Federal;*
>
> · *Entre 7 e 210 Salários Mínimos: Justiça Estadual, com ressarcimento pela União em 65% dos custos; e*
>
> · *Igual ou Inferior a 7 Salários Mínimos: Justiça Estadual, com ressarcimento ao Município, caso este tenha arcado com os custos no processo.*

Como o tratamento do autor se encaixa na segunda opção (entre 7 e 210 salários mínimos) a tramitação da ação deve ser mantida neste juízo e tendo em vista o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é dever do Estado (*lato sensu*) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

Ainda, o STJ ao julgar o REsp .º 1.657.156 (Tema 106), definiu os requisitos para fornecimento de medicamentos não constantes da listagem do SUS, modulando os efeitos, no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.

Nesse sentido a decisão do Recurso Especial n.º 1.657.156/RJ, sendo Relator o Ministro Benedito Gonçalves, publicado no dia 04 de maio de 2018, referente ao TEMA 106 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte ementa:

> *ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.*

Isto é, conforme o julgamento, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3 - existência de registro na ANVISA do medicamento;

No caso dos autos, estes requisitos foram atendidos, pois há laudo médico que demonstra a imprescindibilidade e necessidade de fornecimento dos medicamentos (evento 1, LAUDO14), a incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento e o medicamento está registrado na ANVISA.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL 200MG/ML (PRATI DONADUZZI). TEMA 1234 DO STF. ***FÁRMACO NÃO INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. VEDADA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1234 DO STF. POSSÍVEL O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA.*** *PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50143415720238210008, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 04-07-2024) - grifei*

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA MEDIANTE RECEITA MÉDICA DE CONTROLE ESPECIAL. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 327, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019. TEMA 793 DO STF. ***REAFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS.*** *DIREITO EVIDENCIADO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50020959520238210083, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 04-07-2024) - grifei*

RECURSOS INOMINADOS. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE ALVORADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL 200MG/ML (PRATI DONADUZZI). TEMA 1234 DO STF. FÁRMACO NÃO INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. VEDADA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1234 DO STF. POSSÍVEL O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ.*** *SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.(Recurso Inominado, Nº 50224865420228210003, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Juliana Lima De Azevedo, Julgado em: 04-07-2024) - grifei*

Impõe-se, então, o julgamento de procedência do pedido para o efeito de condenar o réu ao fornecimento do fármaco, devendo a parte autora apresentar, semestralmente, receituário médico atualizado para comprovar a necessidade de manter o tratamento, admitida a denominação comum brasileira.

Isso posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **PROCEDENTE** o pedido veiculado por **GUSTAVO MARCHALEK DE BRITO** na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, para o fim de **condenar** o requerido a disponibilizar o medicamento CANABIDIOL 20MG/ML, 7 caixas/mês, conforme descrito na inicial e no evento 12, DESPADEC1, na quantidade necessária e descrita nos receituários médicos, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento de sua enfermidade, sob pena de bloqueio de valores, mediante apresentação de receituários médicos atualizados, semestralmente, pela parte autora, **TORNANDO DEFINITIVA a tutela antecipada deferida no evento 12, DESPADEC1.**

Condeno o requerido no pagamento dos honorários advocatícios do procurador da parte autora, os quais arbitro em **R$ 1.000,00 (mil) reais,** considerando os termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Isento as partes do pagamento de custas, nos termos do art. 141, §2º, do ECA.

Não é caso de reexame necessário (art. 496, §4º, incisos II e III, do Código de Processo Civil).

Interposto recurso por quaisquer das partes, considerando que não há mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, observando-se o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, subam os autos imediatamente ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sentença publicada e registrada no Eproc.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, nada sendo postulado, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **ROSMERI OESTERREICH KRUGER, Juíza Substituta**, em 24/10/2024, às 17:21:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10070447983v2** e o código CRC **b980a86d**.